

NEURO-REHAB ROBOTICS

让站立重新成为选项

面向 T4 以下完全性脊髓损伤的可穿戴步行外骨骼。

主讲:康复工程团队

本次汇报

01

疾病负担

流行病学与现状

02

诊疗路径

从识别到干预

03

关键指标

疗效与安全

04

现存问题

瓶颈与风险

05

改进方案

下一步计划

06

资源需求

投入与时间表

01



PART ONE

疾病负担

脊髓损伤的流行病学与临床现状

早识别、早干预， 是改变脊髓损伤结局的关键



时间窗决定神经功能的可挽救程度

脊髓损伤的四步管理

■ 早期识别

基于典型症状与量表快速筛查

■ 确诊分型

影像 + 电生理 + 抗体检测

■ 规范治疗

急性期干预与长期维持并重

■ 康复随访

功能评估与并发症防控

* 路径依据最新专家共识

发病机制与干预靶点

病理基础

- 神经元/髓鞘损伤
- 炎症与免疫异常
- 神经环路受累

关键指标(示例)

onset : 急性/亚急性
target : 免疫调节
window : 4.5h
score : mRS 0-2

综合管理的三个维度

A

急性期

快速稳定,把握可逆的治疗时间窗

B

维持期

预防复发,控制疾病活动度

C

康复期

功能重建与生活质量提升

对比 · BEFORE / AFTER

08 规范化管理前后

干预前

分散诊疗

- 识别延迟
- 路径不统一
- 随访脱节

干预后

闭环管理

- 快速通道
- 标准路径
- 全程随访

典型影像表现

脊髓损伤在 MRI/CT 上有其特征性征象,是确诊与分型的重要依据。
规范化的影像采集与判读流程,能显著提升诊断一致性。

“影像必须结合临床与实验室,单一征象不足以定论。”

— 诊断规范

此处放置影像图

本年度诊疗数据

年接诊量

1,240例

↑ 18%

确诊时间

3.2天

↓ 0.8 天

规范治疗率

91%

↑ 6 pt

年复发率

12%

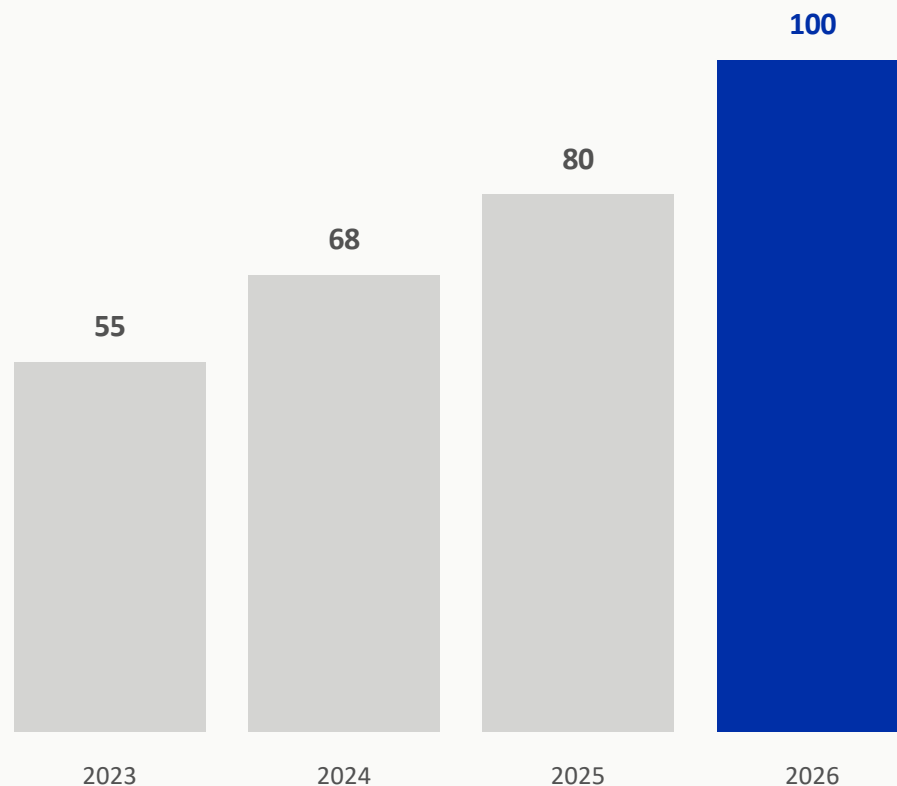
↓ 3 pt

脊髓损伤的核心疗效指标

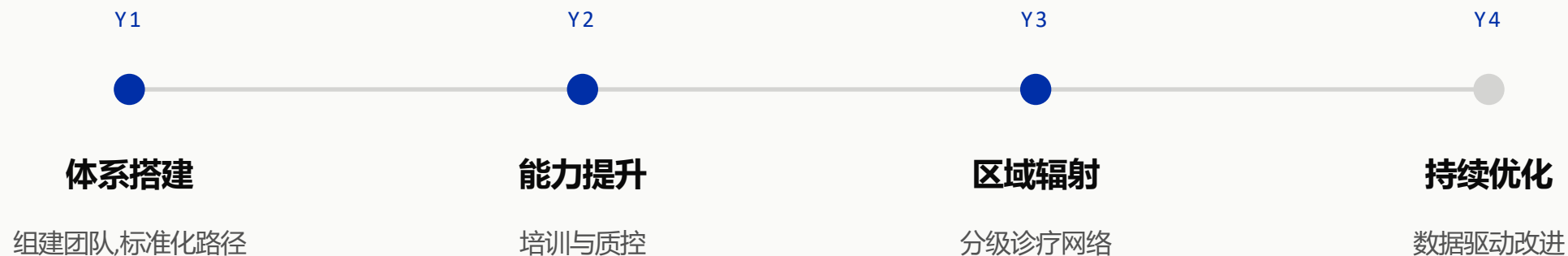
68%

完成院内步行训练的用户占比

8周训练周期内达成10米自主步行的比例。



三年建设时间线



分型与治疗方案

分型	占比	一线方案	预后
经典型	62%	标准治疗	良好
进展型	24%	强化方案	中等
难治型	14%	个体化	需随访

来源: 科室登记数据 2026

急救绿色通道





让每一位脊髓损伤患者都 得到规范诊疗

神经康复外骨骼·产品发布

推进标准化路径落地